内科学含诊断学 内分泌系统疾病

核心精讲·库欣综合征（皮质醇增多症）

（性感认识：激素怎么补看肾上腺怎么切）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、临床表现

①高血压（最早）原醛、库欣、嗜铬细胞瘤最早的表现都是高血压

②ttsx 向心性肥胖（腹型肥胖）、满月脸、水牛背：四肢脂肪分解+躯干脂肪合成 e.g压力大→GC↑→腹型肥胖

③多血质外貌 ①促进骨髓造血，RBC增多，表现为多血质 ②GC分解蛋白质→皮肤变薄，血管更明显

④皮肤紫纹，依赖 ACTH 的库欣综合征可有色素沉着（弹力蛋白分解）

⑤精神异常诱发加重癫痫

⑥骨质疏松和骨折 GC减少肠道、肾对Ca2+吸收 家家苦

⑦低钾碱中毒见于重型库欣病、异位 ACTH 综合征、肾上腺皮质癌（比较严重时才能出现）❌肾上腺皮质瘤

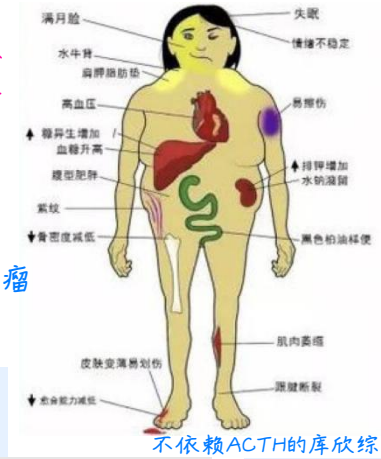
《生理》相似作用：
ACTH↑-促黑素
促胃液素-缩胆囊素
血管活性肠肽-促胰液素
生长激素-催乳素、LH-hCG



小细胞肺癌可引起

GC有较弱醛固酮作用：保钠排水排钾

无论肾上腺皮质功能亢进，还是肾上腺皮质功能减退，都可以有色素沉着
①亢进：依赖ACTH的库欣综合征-ACTH↑（与促黑素作用相似）
②减退：GC↓→ACTH↑



不依赖ACTH的库欣综合征

下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质
CRH↑ ACTH↑↑ GC↑↑↑

依赖ACTH的库欣综合征

二、病因

库欣综合征=皮质醇（GC）增多症

库欣综合征最常见的原因

ACTH↑→GC↑（一）依赖 ACTH 的库欣综合征

库欣病（占库欣综合征 70%）	垂体 ACTH 细胞发生了微腺瘤（占库欣病 80%）、大腺瘤、增生
异位 ACTH 综合征	小细胞肺癌和类癌、胸腺癌等小内裤 因此胸部CT检查有意义
异位 CRH 综合征	罕见

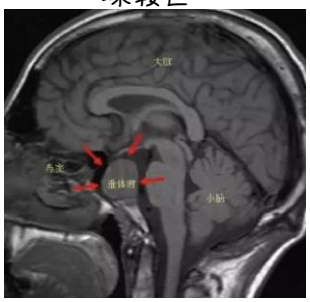
全部都出现双侧肾上腺皮质弥漫增生

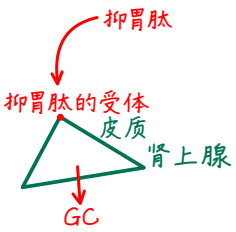
GC↑（二）不依赖 ACTH 的库欣综合征

肾上腺皮质瘤或癌	多为单侧 肿瘤多在单侧 色素沉着不是由于ACTH导致的
双侧肾上腺小结节性增生	多为色素性（原发性色素沉着结节性肾上腺皮质病/Meador 综合征） 若伴皮肤、乳房、心房黏液瘤、睾丸肿瘤、垂体生长激素瘤为 Carney 综合征 （小姐美-卡你个高肤白胸大蛋大心地善良，口诀仅记忆）
双侧肾上腺大结节性增生	如食物依赖性库欣综合征：抑胃肽（小肠产生的激素）受体在肾上腺皮质异位表达→餐后皮质醇分泌增多、而清晨空腹时皮质醇正常或降低 不再符合一般昼夜规律

吃了东西后，促进抑胃肽分泌，作用于肾上腺抑胃肽受体，也会引起GC分泌

蝶鞍区





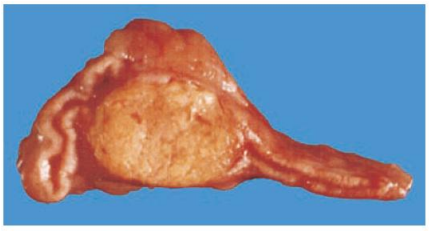
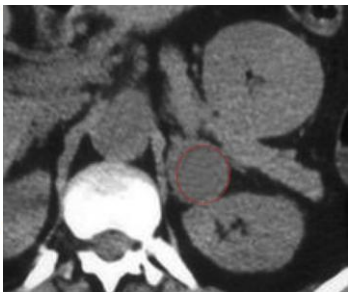


图 15-16 肾上腺皮质腺瘤
肿瘤切面实性，金黄色，有包膜，分界清楚。



GC具有黎明现象的昼夜节律，清晨时分泌↑
而食物依赖性库欣综合症-清晨时没吃东西，没有抑胃肽的释放，也就没有GC↑

X线无法看肾上腺的结构
CT/磁共振才可以